

**CONSULTÓRIO VIRTUAL
Web-Saúde/Ligue-Saúde**

**GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO
REMOTO EM SAÚDE**

Secretaria da Saúde



SECRETÁRIO DA SAÚDE

Jean Rodrigues da Silva

DIRETORIA TÉCNICA DE MEDICINA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mario José Brückheimer

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SERVIÇOS ESPECIAIS

Marlene Bonow Oliveira

GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÃO DA REDE EM SAÚDE

Keli Bett

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Roselaine Elisa Radtke

COORDENAÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Renata Andrade Teixeira Heil

COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Evaristo Cristobal Iglesias Aleman

ELABORAÇÃO

Aline Gabrielle de Souza - Enfermeira - Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde - NARAS

Gyovana da Rosa Goulart - Enfermeira - Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde - NARAS

Janaina Pravato Vicente Banin - Farmacêutica - Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde - NARAS

Lara Cristina Leite Guimarães Machado - Médica da Estratégia de Saúde da Família - Distrito Centro

Maria Simone Pan - Médica da Estratégia de Saúde da Família - Distrito Sul

Martha Maria Vieira de Salles Abreu Artilheiro - Médica da Estratégia de Saúde da Família - Distrito Norte

Simone Afra de Farias - Farmacêutica - Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde - NARAS

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	04
2 ORIENTAÇÕES GERAIS	06
3 EQUIPES CENTRALIZADAS NA SeS	07
3.1 EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO (Preventivo / Papanicolau)	07
3.2 MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO OU DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA	07
3.3 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS / PLANEJAMENTO FAMILIAR	08
3.4 VISITA DOMICILIAR (VD)	08
3.5 INSUMOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO	08
3.6 PRÉ-NATAL	09
3.7 PUERICULTURA	09
3.8 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)	10
3.9 DIABETES MELITTUS TIPO 2 (DM2)	10
3.10 FIBRILAÇÃO ATRIAL (ou outras doenças que resultaram em uso de anticoagulante oral - varfarina)	10
3.11 CONFIRMAÇÃO E CANCELAMENTO DE CONSULTAS	11
4 EQUIPES DA APS	12
4.1 RASTREAMENTO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO	12
4.2 RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA	12
4.3 VISITA DOMICILIAR (VD)	13
4.4 PRÉ-NATAL	13
4.5 PUERICULTURA	13
4.6 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)	14
4.7 DIABETES MELITTUS TIPO 2 (DM2)	14
4.8 FIBRILAÇÃO ATRIAL (ou outras doenças que resultaram em uso de anticoagulante oral - varfarina)	15
4.9 CURATIVOS ESPECIAIS	16
REFERENCIAS	17
ANEXOS	17

1 INTRODUÇÃO

Em decorrência da Pandemia da COVID-19, o Ministério da Saúde (MS) recomendou a adoção de medidas que busca reduzir a presença dos munícipes nos serviços de saúde, especialmente os identificados como grupos de risco – idosos, portadores de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, doença pulmonar crônica, câncer, condições relacionadas à imunossupressão e outras. Neste contexto, a Telemedicina foi regulamentada através da Portaria Ministerial nº 467, de 20 de março de 2020 e as teleconsultas de enfermagem foram normatizadas pela Resolução COFEN nº 0634/2020.

A Secretaria da Saúde de Joinville (SeS) passou a disponibilizar o **atendimento remoto em saúde** a partir de março de 2020, inicialmente com o objetivo de proporcionar à população acesso a informações sobre a pandemia, evitando a circulação das pessoas e diminuindo o risco de exposição ao novo coronavírus. Dois canais foram disponibilizados para essa modalidade de atendimento, inicialmente centralizados na SeS: o **Web-Saúde**, que funciona através do aplicativo de mensagens WhatsApp e o **Ligue-Saúde** para chamadas telefônicas, ambos acessados através do número **3481-5165**.

Atualmente, a SeS amplia o escopo e a capacidade do atendimento remoto, através do **Consultório Virtual**, criando seis novas equipes formadas por médicos e enfermeiros que atuarão em nível central, atendendo ligações de todo o município. Essa ferramenta também será disponibilizada para as equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), que passarão a se comunicar com a sua população adscrita oferecendo um atendimento que tende a se tornar cada vez mais ágil, completo e resolutivo, evitando deslocamentos desnecessários.

Seguindo as recomendações do MS, o atendimento remoto (telefonema, mensagem, e-mail) acontecerá nas seguintes situações:

1. Acompanhamento regular da adesão terapêutica, orientações sobre uso correto de medicações, alimentação saudável, atividade física regular, controle do estresse e outros temas do autocuidado;
2. Disponibilização de medicamentos e insumos;
3. Esclarecimento de dúvidas;
4. Orientação sobre acesso a medicamentos e procedimentos;
5. Reavaliação de plano terapêutico e acompanhamento;
6. Programação de atendimento presencial com segurança.

Além disso, pretende-se colocar em prática as Diretrizes para a Telessaúde no Brasil no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), transpondo barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas, para que os serviços e as informações em saúde cheguem a toda população, resultando

em maior satisfação do usuário, maior qualidade do cuidado e menor custo. As práticas de atendimento remoto devem atender aos princípios básicos de qualidade dos cuidados de saúde (sendo seguro, oportuno, efetivo, eficiente, equitativo, e centrado no paciente), buscar reduzir as filas de espera e o tempo para atendimentos ou diagnósticos e evitar deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde.

2 ORIENTAÇÕES GERAIS

Quando o atendimento remoto evidenciar a necessidade de atendimento presencial, esse será programado conforme estratificação de risco e avaliação da condição clínica. As equipes do consultório virtual na SeS podem agendar consultas presenciais, tendo 40% da agenda das equipes da APS programadas para esse fim. As equipes da APS gerenciam 60% de seus atendimentos destinando, preferencialmente, mais 20% para suas demandas programadas e os restantes 40% para a demanda espontânea, de acordo com sua realidade local.

O Programa Melhor Acolher na APS foi implantado prevendo três diretrizes: facilitador de entrada, recepção resolutiva e escuta qualificada para ampliação do acesso. O consultório virtual passa a ser mais uma modalidade de escuta qualificada. O atendimento realizado em consultório virtual na SeS pode identificar necessidade de atendimento breve pela APS, portanto, estabelecer uma comunicação adequada entre as equipes da SeS e da APS via web-saúde é essencial para que o munícipe tenha o acesso oportuno.

As informações de todos os contatos realizados devem ser registradas no prontuário do paciente (**SIG-Saudetech**) para garantir a longitudinalidade, a coordenação do cuidado, o monitoramento e posterior formulação de políticas e estratégias de saúde. Deverão fazer parte do registro:

- Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchidos em cada contato com o paciente;
- Condutas e orientações realizadas;
- Data, hora, tecnologia da informação e comunicação (TIC) utilizada para o atendimento, com código de procedimento específico.

Observação: Caso o munícipe não tenha prontuário, o cadastro deverá ser realizado no momento do Teleatendimento.

Por fim, as orientações sobre as queixas mais prevalentes ou já descritas em protocolos e linhas guia específicas estão organizadas a seguir e devem ser atualizadas periodicamente a partir do monitoramento da ferramenta.

3 EQUIPES CENTRALIZADAS NA SeS

3.1 EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO (Preventivo / Papanicolau)

Agendar consulta com enfermeiro:

- Mulheres com idade entre 25 e 64 anos; **e**
- Último preventivo realizado há mais de 3 anos independente do resultado; **ou**
- Há um único resultado normal há mais de um ano.

Informar que elas não devem estar menstruadas. Preferencialmente não devem ter relação sexual ou usar duchas ou lubrificantes vaginais nas 24 h anteriores ao exame.

Resultado do exame:

- Informar que a equipe da UBS entrará em contato para orientar; **e**
- Informar a UBS que a usuária entrou em contato solicitando o resultado.

Observação: os exames coletados na APS são avaliados pelo laboratório e o laudo é enviado para o local da coleta, onde as equipes fazem o registro e orientações.

Mulheres com queixa aguda ginecológica: orientar a necessidade de avaliação clínica e agendar consulta médica ou de enfermagem (conforme casos previstos no Protocolo de Enfermagem – Vulvovaginites, instituído pela Portaria N° 242/2018 - Processo SEI N° 18.0.136277-4, documento 2716672).

3.2 MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO OU DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA

Agendar consulta com enfermeiro:

- Mulheres com idade entre 50 e 69 anos; **e**
- Última mamografia realizada há mais de 2 anos.

Caso esteja fora dos critérios anteriores, orientar medidas de prevenção primária, faixa etária e periodicidade do rastreamento. **Mulheres com relato de alteração suspeita das mamas ou com risco elevado de câncer de mama, em qualquer faixa etária: agendar consulta médica na UBS.** Deve ser dada prioridade às mulheres sintomáticas, que já apresentam alguma alteração suspeita na mama.

Resultado do exame:

- Orientar a enviar foto do laudo para o endereço eletrônico da UBS; e
- Informar a UBS que a usuária entrou em contato e enviou o resultado.

3.3 MÉTODOS CONTRACEPTIVOS / PLANEJAMENTO FAMILIAR

- Informar sobre métodos contraceptivos disponíveis na rede;
- Agendar consulta presencial com enfermeiro.

- Caso usuária relate relação sexual desprotegida ou falha no método nos últimos 5 dias orientar procurar no mesmo dia o Melhor Acolher na UBS de referência ou PAs 24h.
- Caso trate-se de situação de violência sexual, encaminhar ao serviço de referência, conforme PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC instituído pelo DECRETO Nº 36.133, de 04 de novembro de 2019. (Processo SEI Nº19.0.164239-6 Documento 4940050).

3.4 VISITA DOMICILIAR (VD)**Agendar visita domiciliar caso haja necessidade de avaliação presencial:**

- Acamados;
- Mobilidade reduzida;
- Recém-nascidos de alto risco (“Carinha Vermelha” na notificação de nascido vivo);
- Alta hospitalar por outros motivos, caso solicitado no resumo de alta;

Outras situações podem ser discutidas com a equipe da APS, que fará busca ativa.

3.5 INSUMOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO**Agendar horário com enfermeiro e orientar documentos: (fazer cadastro?)**

- **Fralda:** prescrição médica, RG, CPF, Cartão SUS e folha resumo Cadastro Único, da Secretaria de Assistência Social, conforme Memorando no 107/2017/SMS/DAF.
- **Glicosímetro e Tiras reagentes:** prescrição médica atualizada SUS (tiras e insulina), RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.
- **Sondas e cateteres:** prescrição médica SUS, RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Orientar contato com a Farmácia da UBS:

- **Fórmulas Alimentares e Nutricionais para situações especiais:** prescrição médica SUS, RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

Observação: Certidão de nascimento para crianças sem RG e CPF.

3.6 PRÉ-NATAL

Agendar com enfermeiro:

- Atraso menstrual igual ou superior a 15 dias se desejam realizar teste de gravidez;
- Gestantes que não tenham iniciado pré-natal na UBS.

Não agendar:

- Sem atraso menstrual ou atraso menor que 15 dias;
- Nos casos de queixas agudas o usuário deve ser orientado a procurar à equipe da APS de referência. A equipe do consultório virtual deverá entrar em contato previamente com a equipe da APS para facilitar o atendimento.

Quando usuária já realiza o pré-natal na UBS: orientar contato direto com a UBS para o agendamento e comunicar equipe da APS para monitoramento via web saúde.

3.7 PUERICULTURA

- Orientar a periodicidade sugerida de consultas de puericultura: 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses e 2 anos; consultas intercaladas entre médico e enfermeiro.

Importante: Os atendimentos presenciais devem ser programados conforme estratificação de risco e avaliação da condição clínica do paciente.

- Caso a criança tenha menos de dois anos e não realize acompanhamento na UBS agendar consulta de enfermagem e comunicar a equipe da APS para monitoramento;
- Nos casos de queixas agudas o usuário deve ser orientado a procurar à equipe da APS de referência. A equipe do consultório virtual deverá entrar em contato previamente com a equipe da APS para facilitar o atendimento.

3.8 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)

Agendar consulta médica:

- Última consulta médica há mais de um ano; **ou**
- Sintomas sugestivos de complicações (ICC, hipotensão postural, doença renal grave, AVC, AIT, angina, IAM, revascularização etc.).

Agendar consulta de enfermagem:

- Última consulta com enfermeiro há mais de um ano e com médico há menos de um ano, sem queixas agudas ou condições que possam ter monitoramento remoto.
- Hipertensos cuja classificação de risco indique acompanhamento mais frequente pela equipe da APS – comunicar a equipe para busca ativa via web-saúde.

3.9 DIABETES MELITUS TIPO 2 (DM2)

Agendar consulta médica:

- Última consulta médica há mais de um ano; **ou**
- Sintomas sugestivos de complicações (ICC, hipotensão postural, doença renal grave, AVC, AIT, angina, IAM, revascularização etc.); **ou**
- Sintomas de hipoglicemia.

Agendar consulta de enfermagem:

- Última consulta com enfermeiro há mais de um ano e com médico há menos de um ano, sem queixas agudas ou condições que possam ter monitoramento remoto.
- Diabéticos cuja classificação de risco indique acompanhamento mais frequente pela equipe da APS – comunicar a equipe para busca ativa.

3.10 FIBRILAÇÃO ATRIAL (ou outras doenças que resultaram em uso de anticoagulante oral - varfarina)

- Solicitar exames para controle de coagulação: tempo de protrombina (TAP)/ razão normalizada internacional (INR) periodicamente;
- Orientar usuários a comunicar aos médicos quando o INR for inferior a 2,0 ou superior a 3,0. Aqueles que mantém o INR entre 2,0 e 3,0 (dois e três) estão bem controlados e podem adiar a consulta.

Avaliação de Exames com Alteração:

- Orientar caso trate-se de ajuste de dose ou relacionado ao autocuidado; ou
- Solicitar novo exame, se necessário; ou
- Comunicar equipe da APS para agendar monitoramento ou busca ativa; ou
- Agendar consulta médica.

Renovação ou Extravio de Receitas:

- Emitir nova receita ou segunda via; **ou**
- Comunicar equipe da APS para agendar monitoramento ou busca ativa; **ou**
- Agendar consulta médica.

3.11 CONFIRMAÇÃO E CANCELAMENTO DE CONSULTAS

- Realizar a confirmação das agendas 72 h antes da consulta.
- Cancelamento de consultas a pedido do munícipe.

4 EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Os atendimentos poderão ser feitos tanto para busca ativa como para orientação de pacientes que busquem contato com sua equipe através dessa ferramenta.

4.1 RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

Realizar busca ativa e agendar consulta com enfermeiro para realização do exame citopatológico de colo uterino (preventivo / papanicolau), se:

- Mulheres com idade entre 25 e 64 anos; e
- Último preventivo realizado há mais de 3 anos independente do resultado; ou
- Há um único resultado normal há mais de um ano.

Resultado do exame:

- **Sem alteração:** orienta o resultado e a rotina de realização (Linha de Cuidado para Controle dos Cânceres de Colo do Útero e Mama, SeS, 2019, Quadro 02).
- **Alterado:** agenda consulta conforme as “Recomendações para conduta inicial frente aos resultados alterados de exames citopatológicos nas unidades de APS” (Linha de Cuidado para Controle dos Cânceres de Colo do Útero e Mama, SeS, 2019, Quadro 02).

Mulheres com queixa aguda ginecológica: orientar a necessidade de avaliação clínica e agendar consulta médica ou de enfermagem (conforme casos previstos no Protocolo de Enfermagem – Vulvovaginites, instituído pela Portaria N° 242/2018, Processo SEI N° 18.0.136277-4, documento 2716672).

4.2 RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Realizar busca ativa e agendar consulta com enfermeiro para solicitação da mamografia, se:

- Mulheres com idade entre 50 e 69 anos; e
- Última mamografia realizada há mais de 2 anos, independente do resultado.

Solicitar que a usuária encaminhe o resultado da mamografia via web/e-mail para avaliação.

Resultado do exame:

- **Sem alteração:** orienta o resultado e a rotina de realização (Linha de Cuidado para Controle dos Cânceres de Colo do Útero e Mama, SeS, 2019, Quadro 07).
- **Alterado:** agenda consulta médica conforme as “Recomendações para conduta inicial frente aos resultados alterados de exames citopatológicos nas unidades de APS” (Linha de Cuidado para Controle dos Cânceres de Colo do Útero e Mama, SeS, 2019, Quadro 07).

Mulheres com relato de alteração suspeita das mamas ou risco elevado de câncer de mama: agendar consulta médica na UBS. Deve ser dada prioridade às mulheres sintomáticas, que já apresentam alguma alteração suspeita na mama.

4.3 VISITA DOMICILIAR (VD)**Busca ativa e agendamento:**

- Acamados;
- Mobilidade reduzida;
- Recém-nascidos de alto risco (“Carinha Vermelha”);
- Alta hospitalar por outros motivos, caso solicitado no resumo de alta;
- Outras situações a critério da equipe.

4.4 PRÉ-NATAL**Busca ativa prevendo a frequência das consultas:**

- Gestante até 32 semanas – mensal;
- De 32 a 36 semanas – quinzenal;
- Após 37 semanas – semanal;
- Puerpério - até 42 dias após o parto.
- **Atendimento conforme Protocolo de Pré-natal de Risco Habitual na Atenção Básica (SeS, 2017)** – consultas médicas e de enfermagem.

4.5 PUERICULTURA

- **Teste do pezinho:** coleta preferencialmente entre o 3º e 5º dia de vida;

- **Busca ativa das crianças menores de 2 anos, prevendo a frequência das consultas, intercaladas entre médico e enfermeiro:** 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses e 2 anos.

Importante: Os atendimentos presenciais devem ser programados conforme estratificação de risco e avaliação da condição clínica do paciente.

4.6 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS):

Monitoramento:

- Utilizar o link de Gestão do Cuidado *Power BI* como ferramenta;
- Considerar classificação de risco para frequência do monitoramento;
- Prever a necessidade de renovação de receitas;
- Informar resultado de exames sem alteração.

Agendar consulta médica:

- Última consulta médica há mais de um ano; **ou**
- Sintomas sugestivos de complicações (ICC, hipotensão postural, doença renal grave, AVC, AIT, angina, IAM, revascularização etc.).

Agendar consulta de enfermagem:

- Última consulta com enfermeiro há mais de um ano e com médico há menos de um ano, sem queixas agudas ou condições que possam ter monitoramento remoto.
- Relato de aumento da pressão arterial.

Renovação de receita à distância pode ser realizada quando:

- Tratamento será mantido sem alterações, a critério médico;
- Consulta médica realizada nos últimos 12 meses e exames sem alterações.

Importante: Os atendimentos presenciais devem ser programados conforme estratificação de risco e avaliação da condição clínica do paciente.

4.7 DIABETES MELITTUS TIPO 2 (DM2)

Monitoramento:

- Utilizar o link de Gestão do Cuidado *Power BI* como ferramenta;
- Considerar classificação de risco para frequência do monitoramento;
- Prever a necessidade de renovação de receitas e insumos;

- Informar resultado de exames sem alteração.

4.8 FIBRILAÇÃO ATRIAL (ou outras doenças que resultaram em uso de anticoagulante oral - varfarina)

- Solicitar exames para controle de coagulação: tempo de protrombina (TAP)/ razão normalizada internacional (INR) periodicamente;
- Orientar usuários a comunicar aos médicos quando o INR for inferior a 2,0 ou superior a 3,0. Aqueles que mantém o INR entre 2,0 e 3,0 (dois e três) estão bem controlados e podem adiar a consulta.

Agendar consulta médica:

- Última consulta médica há mais de um ano; **ou**
- Sintomas sugestivos de complicações (ICC, hipotensão postural, doença renal grave, AVC, AIT, angina, IAM, revascularização etc.); **ou**
- Sintomas de hipoglicemia ou outras queixas agudas.

Agendar consulta de enfermagem:

- Última consulta com enfermeiro há mais de um ano e com médico há menos de um ano, sem queixas agudas ou condições que possam ter monitoramento remoto.

Renovação de receita à distância pode ser realizada quando:

- Tratamento será mantido sem alterações, a critério médico;
- Consulta médica realizada nos últimos 6 meses e exames sem alterações.

Importante: Os atendimentos presenciais devem ser programados conforme estratificação de risco e avaliação da condição clínica do paciente.

Avaliação de Exames com Alteração:

- Orientar caso trate-se de ajuste de dose ou relacionado ao autocuidado; **ou**
- Solicitar novo exame, se necessário; **ou**
- Agendar monitoramento ou busca ativa; **ou**
- Agendar consulta médica.

Renovação ou Extravio de Receitas:

- Emitir nova receita ou segunda via; **ou**
- Agendar consulta médica.

4.9 CURATIVOS ESPECIAIS

Monitoramento pelo enfermeiro:

- O paciente envia fotos para acompanhamento da evolução da ferida;
- Agendar consulta de enfermagem caso não seja possível enviar fotos ou se a evolução da ferida não estiver dentro do esperado.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. SAPS, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. Maio de 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. SAPS, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. NOTA TÉCNICA – ATENÇÃO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NA APS DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19 (CORONAVÍRUS) – 24 de abril de 2020

BRASIL, Ministério da Saúde. SAPS, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. ATENÇÃO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NA APS DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA MINISTERIAL Nº 467, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de COVID-19.

COFEN, Conselho Federal de Enfermagem. RESOLUÇÃO COFEN Nº 634, DE 26 DE MARÇO DE 2020. Autoriza e normatiza, "ad referendum" do Plenário do Cofen, a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com uso de meios tecnológicos, e dá outras providências.

Site: <https://www.saude.gov.br/telessaude> (Acessado em 26 de maio de 2020)

ANEXOS

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME) - Atenção Básica - e ORIENTAÇÕES para Profissionais de Saúde. (Processo SEI 16.0.011530-3. Documento 0302290)

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=10000000337443&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001111&infra_hash=cf0a318ac70851bb37f4672b16e5ebc7998889f29dfde9975ec1fd0891070b9b

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC instituído pelo DECRETO Nº 36.133, de 04 de novembro de 2019. (Processo SEI Nº 19.0.164239-6. Documento 4940050)

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=10000005437017&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001111&infra_hash=6f0e4ca844c55bb29e4a9e1236621a8d4038deea64c9475810f5b52016511026

Linha de Cuidado para Controle dos Cânceres do Colo do Útero e Mama. (Processo SEI N° 19.0.083251-5. Documento 5271973)

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=10000004339800&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001111&infra_hash=07c2b77a32a8b8139deb98060668fc512ac13788a2388add138b1241db7f900a

Linha de Cuidado Saúde da Mulher. PROTOCOLO DE ENFERMAGEM – VULVOVAGINITES. Processo SEI N° 18.0.136277-4. Documento 2716672).

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=10000003013769&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001111&infra_hash=bc82a28755592e1270aa36c5191ee8ff2273f6636b0bd5eff6e869f861e47517